



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
ASURANSI CENTER
TAHUN 2026**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pelayanan Asuransi Center

Tahun 2026

Disusun oleh

Kepala Asuransi Center



Rhizqita Julian Eka Rahmanda, AMd.PK.SKM

Disetujui oleh :

Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M.Kes.,AFP

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Heni Indra Wulandari. S.Kep.M.Kep

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP
2. Heni Indra Wulandari. S.Kep.M.Kep

PENYUSUN

1. Wulandari
2. Rhizqita Julian Eka Rahmanda. A.Md.PK. SKM
3. Aprilia Rose Mawati, Amd. Kes.
4. Ratih Rahmawati. S.Tr.RMIKs
5. Nida Nur Hidayatus Surya, Amd.Kes
6. Aninda Hasri Ainun Nisak, Amd. Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Asuransi Center Rumah Sakit dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pelayanan Asuransi Center di Rumah Sakit meliputi sasaran, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Asuransi Center Rumah Sakit mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 003.6/RSPHS/I-PER/DIR/I/2026

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN ASURANSI CENTER

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu dalam pengklaiman perlu adanya Pedoman Pelayanan asuransi center rumah sakit prima husada sukorejo
2. Bahwa dirasa perlu untuk menetapkan dan memberikan Pedoman Pelayanan asuransi center rumah sakit prima husada sukorejo
3. Bahwa untuk terlaksananya maksud diatas perlu ditetapkan dengan peraturan direktur
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024** tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
3. **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023** tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
4. **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2021** tentang Pedoman *Indonesia Case Base Groups* (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
5. **Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2020** tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
6. **Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020** tentang Sistem Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
7. **Rekomendasi Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Pusat** Atas Hasil Audit Medis Tahun 2025.
8. **Berita Acara Kesepakatan Bersama** Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2024.
9. **Berita Acara Kesepakatan Bersama** Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PEDOMAN
PELAYANAN ASURANSI CENTER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Pedoman Pelayanan asuransi center rumah Sakit adalah suatu tata cara yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit

BAB II

PELAYANAN ASURANSI CENTER

Pasal 2

Rumah sakit menyelenggarakan pengelolaan klaim/pembiayaan kepada pihak ketiga/pihak penjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 3

Penyelenggaraan klaim/pembiayaan dibagi menjadi dua bagian yaitu klaim BPJS Kesehatan dan Non BPJS Kesehatan

Pasal 4

Penyelenggaraan klaim/pembiayaan BPJS Kesehatan berpedoman pada ketentuan dan aturan BPJS Kesehatan sesuai dengan INA CBG

Pasal 5

Penyelenggaraan klaim/pembiayaan asuransi Non BPJS Kesehatan berpedoman pada perjanjian Kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak

Pasal 6

Penggunaan kodefikasi diagnose dan kodefikasi Tindakan sesuai dengan ICD 10 dan ICD 9 CM

BAB III PENUTUP

Pasal 7

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pedoman Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 02 Januari 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Sukorejo



Heni Indra Wulandari. S.Kep.M.Kep

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN2

TIM PENYUSUN.....3

KATA PENGANTAR4

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO.....5

DAFTAR ISI.....8

BAB I.....10

PENDAHULUAN10

1.1. Latar Belakang 10

1.2. Ruang Lingkup 11

1.3. Batasan Operasional 11

1. Pelayanan rawat jalan 11

2. Pelayanan Rawat Inap..... 11

3. Pelayanan IGD 11

1.4. Landasan Hukum..... 11

BAB II.....13

STANDAR KETENAGAAN13

2.1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia 13

2.2. Distribusi Ketenagaan..... 13

2.3. PENGATURAN JAGA 14

BAB III.....15

STANDAR FASILITAS.....15

3.1. Denah Ruang Asuransi Center 15

3.2. Standar Fasilitas Asuransi Center 15

BAB IV16

KEMAMPUAN PELAYANAN.....16

BAB V17

TATA LAKSANA PELAYANAN.....17

5.1. Manfaat pelayanan Non BPJS Kesehatan..... 17

5.2. Manfaat pelayanan BPJS Kesehatan 17

5.3. Pelayanan pasien dengan penjaminan 17

A. Pelayanan Gawat Darurat..... 17

B. Pelayanan Rawat Jalan 18

C. Pelayanan Rawat Inap..... 19

5.4. Penjaminan Bayi Baru Lahir..... 19

5.5. Perawatan sesuai Hak Kelas Penuh 20

5.6. Kenaikan Kelas Perawatan..... 20

5.7. Pelayanan Kesehatan dalam Keadaan Gawat Darurat 22

5.8. Pelayanan Ambulance 23

5.9.	Pelayanan Alat Kesehatan.....	23
5.10.	Pelayanan Rujuk Balik	25
5.11.	Iterasi Obat.....	26
5.12.	Pelayanan Yang Tidak Dijamin	26
5.13.	Sistem <i>Coordination Of Benefit</i> (COB).....	27
5.14.	Dokumentasi klaim	28
5.15.	Verifikasi Klaim	28
5.16.	Laporan Pengajuan Klaim.....	29
5.17.	Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim.....	29
5.18.	Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	29
5.19.	Fragmentasi.....	30
5.20.	Readmisi.....	31
5.21.	Rujukan Semu (<i>Self-Referrals</i>)	31
5.22.	Tagihan Atau Klaim Berulang (<i>repeat billing</i>)	31
5.23.	Memperpanjang Lama Perawatan (<i>Prolonged Length Of Stay</i>)	31
5.24.	Menagihkan Tindakan Yang Tidak Dilakukan	31
5.25.	Episode Perawatan.....	32
5.26.	Rujuk internal.....	33
5.27.	Konsul internal	33
5.28.	Episode Rawat Inap.....	33
5.29.	Pasien Batal Operasi	34
5.30.	TIM Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB).....	34
5.31.	Pelayanan Asuransi Non Bpjs Kesehatan	35
BAB VI		38
LOGISTIK		38
BAB VII		39
KESELAMATAN PASIEN		39
7.1.	Pengertian Keselamatan Kerja	39
7.2.	Tujuan Keselamatan Kerja.....	39
7.3.	Manfaat Keselamatan Kerja.....	39
BAB VIII		40
KESELAMATAN KERJA		40
BAB IX		42
PENINGKATAN MUTU		42
BAB X		43
PENUTUP		43

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR 003.6/RSPHS/I-PER/DIR/II/2026
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN ASURANSI CENTER

PEDOMAN PELAYANAN ASURANSI CENTER

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa derajat kesehatan penduduk Indonesia masih relatif belum baik jika dibandingkan Negara di Asia tenggara. Hal ini berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah ataupun masyarakat untuk kesehatan.

Secara umum kita ketahui juga bahwa biaya kesehatan di Indonesia cenderung meningkat yang disebabkan oleh faktor, diantaranya pola penyakit degenerative, orientasi padapembiayaan kuratif, pembayaran out of pocket atau yang lebih dikenal fee for service secara individual, service yang ditentukan oleh provider, teknologi canggih, perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi ilmu kedokteran, dan tidak lepas juga dari tingkat inflasi. Dengan kondisi dan situasi yang seperti ini maka akses dan mutu pelayanan kesehatan terancam, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini menyebabkan derajat kesehatan masyarakat semakin rendah. Kondisi tersebut diperparah dengan tarif rumah sakit yang tidak standar, sehingga masing-masing rumah sakit cenderung menetapkan tarif tersendiri.

Untuk mencegah permasalahan tersebut , pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 telah memulai sebuah program jaminan kesehatan nasional dengan BPJS Kesehatannya. Akibat perubahan layanan kesehatan yang ada sekarang ini dan meningkatnya biaya kesehatan maka pembiayaan rumah sakit dengan menggunakan asuransi BPJS kesehatan menjadi sangat relevan, dalam asuransi BPJS kesehatan ini maka system manajemen casemix menjadi salah satu pemecahan masalah. Sistem casemix adalah sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan mutu, pemerataan dan keterjangkauan, yang merupakan unsur-unsur dalam mekanisme pembayaran biaya pelayanan kesehatan untuk pasien berbasis kasus campuran prosedur utama

Ada 2 manfaat program casemix ini yaitu manfaat bagi pasien dan manfaat bagi rumah sakit. Manfaat bagi pasien yaitu adanya kepastian dengan dalam pelayanan pengobatan berdasarkan derajat keparahan, adanya target lama hari

rawat pasien untuk mendapatkan perhatian lebih dalam tindakan medis dari petugas rumah sakit, mendapat kualitas kesehatan yang lebih baik, menerima sediaan farmasi alat kesehatan bahan habis medis habis pakai sesuai dengan spesifikasi yang berlaku, serta mengurangi pemeriksaan dan penggunaan alat medis yang berlebihan oleh tenaga medis sehingga mengurangi resiko yang dihadapi oleh pasien. Adapun manfaat bagi rumah sakit yaitu mendapat pembiayaan sesuai dengan beban kerja, meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan, bagi dokter atau klinisi dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk kualitas pelayanan lebih baik, perencanaan budget anggaran pembiayaan dan belanja lebih akurat, dapat mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing klinisi, serta mendukung system perawatan pasien dengan menerapkan clinical pathway.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelayanan asuransi center adalah pasien rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat yang menggunakan penjaminan baik itu BPJS Kesehatan, asuransi swasta dan jaminan lainnya

1.3. Batasan Operasional

Batasan operasional asuransi center rs prima husada menjacuk tiga macam pelayanan yang berkaitan langsung dengan pasien

1. Pelayanan rawat jalan

Pelayanan rawat jalan yang ditujukan kepada poli spesialis sesuai dengan daftar jadwal praktek dokter di RS Prima Husada dengan membawa syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing penjamin

2. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap di RS Prima Husada dilakukan dengan sistem yang berjenjangsetelah melalui poli spesialis atau unit gawat darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Pelayanan IGD

Pelayanan IGD diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing penjamin, dan sesuai dengan derajat kegawatan pasien.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

-
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2020 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standart tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Indonesia *Case Base Groups* (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 3 Tahun 2023 Tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
 10. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
 11. Panduan Manual Verifikasi Klaim INA-CBG Edisi 2 Tahun 2018
 12. Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2018
 13. Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019
 14. Berita Acara Rekomendasi TKMKB Provinsi Jawa Timur terkait Dispute Klaim Bulan Juni 2022
 15. Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2023
 16. Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2024
 17. Rekomendasi Tim Kendali Mutu Kendali Biaya Tingkat Pusat Atas Hasil Audit Medis Tahun 2025

BAB II
STANDAR KETENAGAAN

2.1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mempersiapkan tenaga asuransi center, perlu kiranya melakukan kegiatan menyediakan, mempertahankan sumber daya manusia yang tepat bagi organisasi.

Atas dasar tersebut perlu adanya perencanaan sumber daya manusia, yaitu proses mengantisipasi dan menyiapkan perputaran orang ke dalam, di dalam dan ke luar organisasi. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

Tabel 2.1 Kualifikasi sumber daya manusia

No	Nama jabatan	Kualifikasi pendidikan	Jam kerja	jumlah
1	Kepala unit asuransi center	Lulusan D3/S1 kesehatan	08.00-16.00	1 orang
2	Koder rawat jalan	Lulusan D3/D4 rekam medis	06.30-14.00 14.00-21.00	4 orang
3	Koder rawat inap	Lulusan D3/D4 Rekam Medis	06.30-14.00 14.00-21.00	6 orang
4	Admin jaminan	Lulusan D3/S1 keuangan/akuntansi	06.30-14.00 14.00-21.00	2 orang

2.2. Distribusi Ketenagaan

Tabel 2.2 Distribusi Ketenagaan

NAMA JABATAN	Waktu Kerja	JML SDM
Kepala unit	1 Shift	1
Koder rawat jalan	2 shift	4
Koder rawat inap	2 Shift	6
Admin jaminan	2 Shift	2

2.3. PENGATURAN JAGA

Tabel 2.3. Pengaturan Jaga tim asuransi center

NO	SHIFT	JAM
1	Pagi	06:30 - 14:00
2	Siang	14:00 - 21:00
3	Non Shift	08.00 – 16.00
4	Midle	10.00 – 18.00

BAB III

STANDAR FASILITAS

3.1. Denah Ruang Asuransi Center

(terlampir)

3.2. Standar Fasilitas Asuransi Center

1. Perlengkapan

Tabel 3.1 Daftar inventaris perlengkapan asuransi center

No	Nama Barang	Jumlah (unit/buah)
1	Komputer	10
2	Printer Epson	1
3	Printer dotemetrik	1
4	Scanner	4
5	Meja	10
6	Kursi	10
7	AC	1
8	Almari	1
9	Rak dokumen	1

2. Kelengkapan bangunan
- 1. Pencahayaan yang cukup
 - 2. Kelembaban/suhu ruangan yang cukup untuk penyimpanan dokumen
 - 3. Ventilasi yang cukup

BAB IV

KEMAMPUAN PELAYANAN

4.1. Kemampuan Sumber Daya Manusia

1. Memiliki petugas klaim yang memahami regulasi dan kebijakan BPJS Kesehatan dan non BPJS Kesehatan
2. Petugas mampu melakukan
 - a. Verifikasi administrasi dan eligibilitas peserta
 - b. Pengkodingan dan tindakan sesuai standar ICD 10 dan ICD 9CM
 - c. Input data klaim pada aplikasi E-klaim

4.2. Kemampuan Administratif

1. Kelengkapan dokumen klaim sesuai ketentuan
2. Ketepatan waktu pengajuan klaim sesuai jadwal yang telah ditetapkan
3. Tersedianya sistem dokumentasi yang tertata dan mudah ditelusuri

4.3. Kemampuan Sistem Dan Teknologi

1. Memiliki perangkat dan jaringan yang memadai untuk akses aplikasi BPJS Kesehatan dan non BPJS Kesehatan
2. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data pasien

4.4. Kemampuan Verifikasi Internal

1. Tersedianya mekanisme pengecekan internal sebelum klaim diajukan
2. Adanya evaluasi berkala terhadap klaim pending dan audit

4.5. Kemampuan Koordinasi Dan Komunikasi

1. Mampu berkoordinasi dengan unit pelayanan terkait dengan rekam medis pasien
2. Mampu berkomunikasi dengan verifikator bpjs kesehatan secara profesional dan responsif

BAB V

TATA LAKSANA PELAYANAN

5.1. Manfaat pelayanan Non BPJS Kesehatan

Manfaat Pelayanan Kesehatan bagi peserta Non BPJS kesehatan sesuai dengan manfaat yang didapatkan oleh masing-masing individu

5.2. Manfaat pelayanan BPJS Kesehatan

Manfaat Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) bagi pasien BPJS Kesehatan mencakup:

1. Administrasi pelayanan
2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis dasar
3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisik
4. Tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun nonbedah sesuai dengan indikasi medis
5. Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
6. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis
7. Rehabilitasi medis
8. Pelayanan darah
9. Perawatan inap non intensif
10. Pelayanan keluarga berencana dengan indikasi medis
11. Perawatan inap di ruang intensif

5.3. Pelayanan pasien dengan penjaminan

A. Pelayanan Gawat Darurat

1. Peserta datang ke IGD RS dalam kondisi emergency
2. Petugas IGD melakukan save saving pada pasien
3. Petugas IGD mengarahkan keluarga pasien untuk datang ke tempat pendaftaran pasien
4. Petugas menanyakan identitas pasien yang meliputi Kartu identitas peserta JKN-KIS/KIS/Kartu asuransi lain Digital dan non digital yang aktif, Identitas lain (KTP, SIM, KK) jika diperlukan
5. Peserta menandatangani bukti pelayanan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan
6. Rumah Sakit menerbitkan surat jaminan/Surat Eligibilitas Peserta (SEP)

7. Jika pasien masuk rawat inap maka petugas melakukan cetak surat jaminan/SEP rawat inap dengan bukti cetak menggunakan surat pengantar rawat inap (SPRI)
8. Jika pasien rawat jalan maka petugas menerbitkan surat jaminan/Surat Eligibilitas Peserta

B. Pelayanan Rawat Jalan

1. Peserta datang ke RS tujuan dengan menunjukkan
2. Kartu identitas peserta JKN-KIS/KIS/asuransi lain Digital atau non digital yang aktif, Identitas lain (KTP, SIM, KK) jika diperlukan
3. Surat rujukan bagi peserta JKN/KIS atau peserta asuransi lain yang masih aktif
4. Rumah Sakit menerbitkan Surat jaminan/Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
5. Atas indikasi medis peserta dapat dirujuk ke Poli Spesialis lain dengan surat rujukan dan surat rujukan internal atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan lain dengan surat rujukan dan rujukan eksternal.
6. Apabila atas indikasi medis peserta masih memerlukan perawatan lanjutan di Rumah Sakit, maka dokter FKRTL akan memberikan surat kontrol ulang yang digunakan sebagai pengganti surat rujukan pada kunjungan berikutnya
7. Apabila perawatan selanjutnya dapat ditangani di FKTP, maka dokter di FKRTL akan memberikan surat rujuk balik (SRB) yang ditujukan ke dokter FKTP tempat peserta terdaftar.
8. Apabila peserta menghendaki pelayanan rawat jalan eksekutif/VIP berlaku ketentuan sebagai berikut:
9. Peserta PBI dan Peserta dari Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tidak diperkenankan memilih pelayanan rawat jalan Eksekutif/VIP.
10. Peserta mengikuti prosedur sistem rujukan untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan eksekutif.
11. Pembayaran Selisih Biaya pelayanan rawat jalan eksekutif dilakukan dengan ketentuan membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap episode rawat jalan. Besar Biaya ini hanya untuk peserta JKN/KIS. Bagi peserta asuransi Swasta maupun perusahaan mengikuti kesepakatan sesuai dengan perjanjian kerjasama
12. Pelayanan rawat jalan eksekutif hanya dijamin di RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan poli eksekutif.

C. Pelayanan Rawat Inap

1. Merupakan tindak lanjut dari pelayanan FKTP, instalasi gawat darurat, dan Poli Rawat Jalan atau Rujukan dari FKRTL lain.
2. Peserta mendapatkan rujukan dari FKTP/ FKRTL lain atau surat perintah rawat inap oleh Dokter Poli Rawat Jalan, kecuali kasus Gawat Darurat.
3. Peserta datang ke FKRTL tujuan rujukan dengan menunjukkan kartu identitas peserta JKN-KIS/KIS atau asuransi lain Digital/non digital dengan status aktif dan/atau identitas lain yang diperlukan (KTP, SIM, KK).
4. Peserta melengkapi persyaratan administrasi untuk penerbitan Surat jaminan/Surat Eligibilitas Peserta (SEP), maksimal 3 x 24 jam hari kerja sejak masuk rumah sakit atau sebelum pulang jika waktu rawat inap nya kurang dari 3x24 jam
5. Peserta menandatangani bukti pelayanan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan
6. Peserta mendapatkan perawatan pada kelas rawat sesuai haknya.
7. Jika peserta ingin mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan hak pelayanan yang peserta miliki maka peserta harus menambah biaya pelayanan sesuai dengan PMK No 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

5.4. Penjaminan Bayi Baru Lahir

1. Apabila bayi baru lahir sehat, maka penjaminan bayi masuk pada penjaminan ibu.
2. Apabila bayi baru lahir sakit, maka dibuatkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) tersendiri dengan biaya perawatan terpisah dari paket Ibu. Untuk bayi sakit non NICU maka penjaminan bayi menggunakan kelas 3. Pada bayi baru lahir sakit masuk NICU maka penjaminan sesuai dengan hak kelas peserta atau bayi baru lahir
3. Batas akhir manfaat jaminan kesehatan berakhir paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan. Jika paling lama 28 (dua puluh delapan) hari iuran belum dibayarkan maka jaminan pelayanan kesehatan dibatalkan sejak bayi baru lahir.

5.5. Perawatan sesuai Hak Kelas Penuh

Dalam hal kelas perawatan penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dan paling lama 3 (tiga) hari sampai ruang sesuai hak kelasnya tersedia. Namun, jika kelas rawat yang sesuai hak serta kelas rawat 1 tingkat lebih tinggi juga penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan 1 (satu) tingkat lebih rendah dan paling lama 3 (tiga) hari sampai ruang sesuai hak kelasnya tersedia.

Jika kenaikan kelas perawatan lebih dari 3 (tiga) hari dan masih tetap penuh, maka selisih biaya atas kenaikan kelas menjadi tanggung jawab Fasilitas kesehatan atau berdasarkan persetujuan peserta jika dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang setara dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, namun bila peserta tidak bersedia untuk dirujuk dan tetap menginginkan untuk dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi maka peserta berkewajiban membayarkan selisih biaya yang timbul.

5.6. Kenaikan Kelas Perawatan

Dalam hal peserta menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1. Peserta PBI dan Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah gugur haknya apabila memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya.
- 2. Peserta Bukan PBI, dapat meningkatkan kelas perawatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib membayar sendiri seluruh selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 5.1 ketentuan naik kelas

Huruf	Jenis Perawatan	Ketentuan Selisih Biaya
A	Rawat jalan eksekutif	Paling banyak sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
B	Hak rawat kelas 2 naik ke kelas 1	Selisih tarif INA CBG pada kelas rawat inap kelas 1 dengan tarif INA CBG pada kelas rawat inap kelas 2
C	Hak rawat kelas 1 naik ke kelas diatas kelas 1	Selisih tarif INA CBG kelas 1 dengan tarif kelas diatas kelas 1 yaitu paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif INA CBG kelas 1
D	Hak rawat kelas 2 naik ke kelas diatas kelas 1	Selisih tarif INA CBG antara kelas 1 dengan kelas 2 ditambah paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif INA CBG kelas 1

3. Ketentuan selisih biaya hak rawat kelas 1 naik ke kelas diatas kelas 1 dan hek kelas 2 naik ke kelas diatas kelas 1 sebagaimana dimaksud tidak berlaku apabila biaya pelayanan rawat inap di FKRTL tidak melebihi tarif INA CBG sesuai hak peserta. Peserta membayar tambahan biaya, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap dari kelas perawatan II ke kelas I, membayar selisih biaya antara Tarif INA-CBG pada kelas rawat inap lebih tinggi yang dipilih dengan Tarif INA-CBG pada kelas rawat inap yang sesuai dengan hak Peserta, dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

Contoh : Pasien A (hak kelas rawat di kelas II) dirawat inap di kelas I

Tarif INA-CBG kelas I = Rp 5.000.000

Tarif INA-CBG kelas II = Rp 4.000.000

Tambahan biaya yang dibayar peserta maksimal sebesar $(Rp5.000.000 - Rp4.000.000) = Rp1.000.000$

- b. Untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap di atas kelas perawatan I, membayar selisih biaya paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Tarif INA-CBG kelas perawatan I

Contoh : Pasien B (hak kelas rawat di kelas I) dirawat inap di kelas VIP.

Tarif VIP = Rp. 10.000.000

Tarif INA CBG kelas 1 = Rp. 5.000.000

Tambahan biaya maksimal sebesar

$(75\% \times Rp. 5.000.000) = Rp. 3.750.000$

- c. Untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap dari kelas II ke kelas diatas kelas I atau VIP pembayaran selisih biaya kelas 1 dengan kelas 2 ditambah paling banyak 75%

Contoh : Pasien C (hak kelas II naik kelas VIP)

Tarif VIP = Rp. 15.000.000

Tarif kelas I = Rp. 4.803.200

Tarif kelas II = Rp. 4.207.300

$(Rp. 4.803.200 - Rp. 4.207.300 + (4.803.200 \times 75\%)) = Rp. 4.198.300$

5.7. Pelayanan Kesehatan dalam Keadaan Gawat Darurat

Pelayanan Gawat Darurat meliputi pengertian dan batasan, prosedur pelayanan di Faskes yang bekerja sama maupun tidak bekerja sama, sebagai berikut :

1. Pengertian dan batasan

Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya kepada pasien untuk mencegah kematian, keparahan dan/ atau kecacatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan
- b. Adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi;
- c. Adanya penurunan kesadaran;
- d. Adanya gangguan hemodinamik; dan/atau
- e. Memerlukan tindakan segera.
- f. Penetapan terpenuhinya kriteria gawat darurat ditetapkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan dokter IGD yang menanganin.

2. Prosedur pelayanan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan:

- a. Pelayanan gawat darurat medis diberikan oleh FKRTL baik yang bekerjasama maupun tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- b. Pelayanan gawat darurat medis di FKRTL diberikan di FKRTL tanpa memerlukan surat rujukan dari FKTP.
- c. Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan gawat darurat medis yang termasuk dalam pelayanan yang dijamin dalam jaminan kesehatan nasional baik yang bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dilarang meminta atau menarik biaya kepada Peserta.
- d. Peserta datang ke FKRTL terdekat dengan menunjukan kartu identitas peserta JKN-KIS/KIS Digital dengan status aktif dan/atau identitas lain yang diperlukan (KTP, SIM, KK), tanpa surat rujukan dari FKTP.
- e. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh masing-masing fasilitas kesehatan.

5.8. Pelayanan Ambulance

Pelayanan Ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan untuk menjaga kestabilan kondisi dan keselamatan pasien yang meliputi pelayanan ambulan darat dan ambulan air untuk rujukan pada. Syarat pelayanan ambulance di FKRTL yang dijamin adalah rujukan antarfasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Pelayanan ambulan tidak dijamin jika:

1. Jemput pasien selain dari fasilitas kesehatan (rumah, jalan, lokasi lain);
2. Mengantar pasien ke selain fasilitas kesehatan;
3. Rujukan parsial (antar jemput pasien atau spesimen dalam rangka mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan, yang merupakan rangkaian perawatan pasien di salah satu fasilitas kesehatan);
4. Mengantar jenazah; dan
5. Pasien rujuk balik rawat jalan.

Adapun prosedur pelayanan ambulan sebagai berikut:

1. Pasien yang mendapatkan pelayanan ambulan adalah pasien yang memerlukan evakuasi ke fasilitas kesehatan lain sesuai indikasi medis dan ketentuan penjaminan ambulan.
2. Pelayanan ambulan dijamin bila rujukan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau pada kasus gawat darurat dari fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
3. Fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas ambulan dapat langsung memberikan pelayanan ambulan bagi pasien.
4. Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki fasilitas ambulan, maka Fasilitas kesehatan berkoordinasi dengan penyedia ambulan.

5.9. Pelayanan Alat Kesehatan

Penjaminan alat kesehatan untuk pasien dengan kartu JKN/KIS yang akan di tanggung oleh oleh BPJS Kesehatan meliputi jenis dan nilai ganti serta prosedur pelayanannya.

a. Jenis alat kesehatan dan nilai ganti

Tabel 5.2. Jenis Alat Kesehatan dan Nilai Ganti

No	Nama Alat Kesehatan	Syarat	Nilai Ganti
1	Kacamata	Min. Sferis 0,5D, Silindris 0,25D. PalingCepat 2 (dua) tahun sekali sesuai indikasi medis Diberikan berdasarkan resep dari dokter spesialis mata	Kelas 3: Rp165.000 Kelas 2: Rp 220.000 Kelas 1: Rp 330.000
2	Alat bantu dengar	5.9.3.1. Paling cepat 5 (lima)tahun sekali dengan indikasi medis 5.9.3.2. Diberikan berdasarkan resep dari dokter spesialis THT	Maksimal Rp1.100.000
3	Protesa gigi	Paling cepat 2 (dua) tahun sekali sesuai indikasi medis untuk gigi yang sama	1. Maksimal Rp1.100.000 untuk gigi yang sama 2. full protesa Maksimal Rp500.000 untuk masing-masing rahang
4	Protesa alat gerak	1. Paling cepat 5 (lima)tahun sekali sesuai indikasi medis 2. Alat bantu gerak berupa kaki palsu dan tangan palsu 3. Diberikan berdasarkan resep dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi	Maksimal Rp2.750.000

5	Korset tulang belakang	Paling cepat 2 (dua) tahun sekali sesuai indikasi medis	Maksimal Rp385.000
6	Collar neck	Paling cepat 2 (dua) tahun sekali sesuai indikasi medis	Maksimal Rp165.000
7	Kruk	Paling cepat 5 (lima) tahun sekali sesuai indikasi medis	Maksimal Rp385.000

- b. Prosedur pelayanan alat kesehatan
1. Mengikuti prosedur pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) yang berlaku bagi peserta JKN-KIS.
 2. Dokter spesialis di FKRTL memberikan resep alat kesehatan untuk diambil di Apotek/ Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
 3. Pengajuan nilai ganti diajukan oleh Apotek/ Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

5.10. Pelayanan Rujuk Balik

Program Rujuk Balik (PRB) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/sub spesialis yang merawat. Penyakit kronis yang termasuk dalam cakupan PRB adalah diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), epilepsy, gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke dan sindroma lupus eritematosus (SLE).

Untuk mendapatkan manfaat pelayanan Program Rujuk Balik maka Peserta mendaftarkan diri sebagai peserta PRB kepada petugas Rumah Sakit (PIC PRB) dengan membawa:

1. Surat Rujuk Balik (SRB) dari Dokter Spesialis/ Sub Spesialis yang merawat;
2. Resep obat PRB;
3. Hasil pemeriksaan penunjang (jika diperlukan).

Setelah menjadi Peserta PRB, maka peserta datang ke FKTP tempat Peserta terdaftar dengan membawa:

1. Kartu Identitas Peserta JKN-KIS atau JKN-KIS Digital;
2. SRB dan resep/copy resep obat PRB;

-
3. Buku pemantauan Peserta PRB-Prolanis (bagi yang sebelumnya telah mendapatkannya) Selanjutnya Peserta akan mendapatkan obat untuk kebutuhan paling banyak 30 (tiga puluh) hari di Apotek PRB/ruang farmasi Puskesmas/Instalasi Farmasi Klinik Pratama yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memberi pelayanan obat PRB.

5.11. Iterasi Obat

Merupakan proses pemberian obat berdasarkan resep yang telah ada sebelumnya tanpa perlu pemeriksaan kembali ke dokter. Iterasi dapat diberikan maksimal dua kali, iterasi dapat dilakukan pada kondisi pasien yang sudah stabil.

5.12. Pelayanan Yang Tidak Dijamin

Penjaminan pasien asuransi yang datang ke pelayanan Kesehatan maka harus disesuaikan dengan polis yang ada pada surat jaminan awal yang telah dicetak sebelum pasien mendapatkan pelayanan.

Untuk pasien JKN/KIS ada beberapa pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan antara lain:

1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat
3. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
4. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta
5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
8. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
9. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;

-
11. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
 12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
 13. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik
 14. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
 15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luarbiasa/wabah;
 16. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
 17. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
 18. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 19. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 20. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatanyang diberikan;
 21. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

5.13. Sistem *Coordination Of Benefit* (COB)

COB merupakan sistem dimana pasien dapat sharing benefit dengan asuransi tambahan yang dimiliki oleh pasien. Dimana asuransi tambahan merupakan asuransi kesehatan komersial yang dibeli secara sukarela diluar asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib.

Pada peserta JKN/KIS yang ingin menggunakan pelayanan tidak sesuai dengan hak peserta atau menempati kelas perawatan yang lebih tinggi maka dapat menggunakan benefit COB dengan asuransi swasta yang dimiliki. Mekanisme penggunaan COB pada program JKN sesuai dengan ketentuan dari masing-masing asuransi.

Peserta JKN/KIS dapat meningkatkan perawatan lebih tinggi dari hak nya yaitu:

1. Rawat jalan
Rawat jalan biasa ke rawat jalan eksekutif
2. Rawat inap
Peningkatan hak kelas perawatan. Misal dari :
 - a. kelas 2 ke 1
 - b. kelas 2 ke VIP
 - c. kelas 1 ke VIP

RS akan menagihkan tagihan ke BPJS Kesehatan sebagai pembayar pertama sesuai ketentuan yang berlaku dan RS akan menagihkan selisih biaya pelayanan ke pihak asuransi tambahan sebagai pembayar kedua sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan

5.14. Dokumentasi klaim

Dokumentasi klaim adalah dokumen yang dibutuhkan dalam kelengkapan administrasi klaim per peserta asuransi. Berikut dokumen klaim:

1. Rawat Jalan

- a. Kartu Asuransi
- b. Identitas pasien (KTP/SIM/KK)
- c. Surat Rujukan/rujukan internal/konsul internal
- d. Surat Kontrol jika dibutuhkan
- e. Surat Jaminan atau SEP
- f. Lembar Casemix/Resume medis rawat jalan/lembar asuransi sesuai ketentuan asuransi
- g. Hasil penunjang jika ada
- h. Laporan operasi jika ada

2. Rawat Inap

- a. Kartu Asuransi
- b. Identitas pasien (KTP/SIM/KK)
- c. Surat Rujukan/Surat Pengantar Rawat Inap
- d. Surat Jaminan atau SEP
- e. Lembar Casemix/Resume medis rawat inap/ lembar asuransi sesuai daripayor
- f. Hasil penunjang jika ada
- g. Laporan operasi jika ada
- h. Lembar ICU jika ada

5.15. Verifikasi Klaim

Verifikasi klaim merupakan proses penilaian klaim yang dilakukan oleh tenaga asuransi center pada dokumen klaim. Pada verifikasi klaim dibagi menjadi 3 hal yaitu:

1. Verifikasi administrasi

Verifikasi administrasi pada dokumen klaim meliputi kelengkapan dokumen klaim, kesesuaian no kartu peserta dengan surat jaminan

2. Verifikasi Klinis

Verifikasi klinis meliputi keseuaian antara anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis dan tata laksana pelayanan yang telah diberikan kepada pasien dan telah di dokumentasikan pada lembar klaim atau rekam medis.

3. Verifikasi Koding

Pada verifikasi koding digunakan hanya untuk verifikasi klaim pada BPJS Kesehatan. Pada verifikasi koding harus melihat:

1. kondisi klinis pasien
2. Aturan ICD 10 dan ICD 9 CM

5.16. Laporan Pengajuan Klaim

Jenis laporan yang harus dibuat oleh asuransi untuk pengajuan ke pihak pembayar meliputi:

1. Surat pengajuan berkas klaim
2. Ceklist berkas klaim
3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
4. Surat pernyataan pemeriksaan klaim oleh tim pencegahan kecurangan
5. Lampiran dokumen klaim dan TXT Laporan ini harus dibuat setiap bulan pelayanan

5.17. Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim

Berita acara merupakan berkas yang diberikan oleh BPJS kesehatan kepada Rumah Sakit setelah selesai proses verifikasi klaim

1. Laporan berita acara hasil verifikasi
2. Laporan berita acara serah terima klaim
3. Laporan rincian data hasil verifikasi rawat jalan dan rawat inap

5.18. Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu jenis pelaku kecurangan (*fraud*) di asuransi adalah FKRTL. Berikut ini adalah jenis-jenis kecurangan yang dilakukan oleh FKRTL:

1. memanipulasi diagnosis dan/atau tindakan tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan besaran klaim dengan cara memalsukan diagnosa dan/atau tindakan medis
2. pasien seharusnya didiagnosis *apendicitis* akut, setelah operasi tanpa penyulit tetapi di resume/rekam medis ditulis *apendicitis* akut dengan perforasi
3. pasien dengan tindakan laserasi grade 2 tetapi diresume medis diganti lacerasi grade 3

-
4. penjiplakan klaim dari pasien lain (*cloning*) klaim yang dibuat dengan cara menyalin dari klaim pasien lain yang sudah ada, seperti: menyalin (*copy paste*) seluruh atau sebagian rekam medis dan/atau data pasien lain.
 5. klaim palsu (*Phantom billing*)
klaim atas layanan yang tidak pernah dilakukan/diberikan kepada pasien, seperti:
 - a. Penagihan tindakan medik operatif yang tidak pernah dilakukan; dan
 - b. Penagihan obat/alat kesehatan di luar paket INA-CBG yang tidak diberikan kepada pasien.
 6. penggelembungan tagihan obat dan/atau alat kesehatan (*Inflated bills*) klaim atas biaya obat dan/atau alat kesehatan yang lebih besar dari biaya yang sebenarnya
 7. pasien patah tulang dilakukan operasi ortopedi dengan menggunakan *plate and screw* 4 (empat) buah, namun ditagihkan lebih dari 4 (empat) buah.
 8. obat pasien penyakit kronis pada rawat jalan yang seharusnya mendapat obat 1 (satu) bulan, tetapi obat yang diberikan untuk 2 minggu, namun ditagihkan biayanya selama 1 (satu) bulan.
 9. pasien kemoterapi yang membutuhkan obat kemo sebanyak 2 (dua) vial diklaimkan menjadi 4 (empat) vial.

5.19. Fragmentasi

kunjungan rawat jalan berulang di FKRTL yang sama pada kasus dengan diagnosis yang sama dari episode rawat jalan sebelumnya dalam waktu kurang atau samadengan hari. Kondisi yang dikecualikan dari fragmentasi adalah sebagai berikut:

1. alam kondisi kegawatdaruratan sesuai regulasi yang berlaku;
2. penyakit kronis;
3. rangkaian tindakan/prosedur/*post* prosedur yang terjadwal oleh dokter/fasilitas kesehatan sesuai indikasi medis dan tidak dapat dilakukandalam satu episode; atau
4. konsultasi hasil pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilakukan dalam satu episode.

5.20. Readmisi

kunjungan rawat inap berulang di FKRTL yang sama dengan diagnosis utama yang sama dari episode rawat inap sebelumnya dalam waktu kurang atau sama dengan 30 hari. Kondisi yang dikecualikan dari readmisi yaitu sebagai berikut:

1. dalam kondisi kegawatdaruratan sesuai regulasi yang berlaku;
2. penyakit kronis;
3. tindakan/prosedur/*post* prosedur yang terjadwal oleh dokter/fasilitas kesehatan sesuai indikasi medis dan tidak dapat dilakukan dalam satu episode; atau
4. kunjungan pada FKRTL yang berbeda atau kelas FKRTL yang lebih tinggi.

5.21. Rujukan Semu (*Self-Referrals*)

klaim atas biaya pelayanan akibat rujukan ke rumah sakit tertentu atau ke dokter yang sama di Fasilitas Kesehatan lain kecuali dengan alasan keterbatasan fasilitas, seperti:

1. pasien masuk dengan kasus rencana akan di operasi tetapi dokter tidak mau mengoperasi di rumah sakit tersebut karena jasa operasi yang didapatkan sedikit sehingga pasien dirujuk ke rumah sakit tertentu dimana dokter juga bekerja di rumah sakit tersebut.
2. melakukan rujukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien ke rumah sakit dimana dokter itu berdinass.

5.22. Tagihan Atau Klaim Berulang (*repeat billing*)

klaim yang diulang pada kasus yang sama, seperti: Tagihan yang sudah pernah ditagihkan dan dibayarkan tetapi ditagihkan ulang

5.23. Memperpanjang Lama Perawatan (*Prolonged Length Of Stay*)

klaim atas biaya pelayanan kesehatan yang lebih besar akibat perubahan lama hari perawatan inap bukan karena indikasi medis, seperti:

1. penggunaan ventilator yang diperpanjang waktunya tanpa indikasi medis; dan
2. *Case Main Group* (CMG) khusus untuk penyakit jiwa dan penyakit kusta

5.24. Menagihkan Tindakan Yang Tidak Dilakukan

klaim atas diagnosis dan/atau tindakan yang tidak jadi dilaksanakan, seperti:

1. pada pasien Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) dengan rencana tindakan biopsi, tidak jadi dilakukan tindakan karena alasan tertentu namun tindakan biopsi tetap ditagihkan ke BPJS Kesehatan; dan

2. pasien dengan indikasi rawat inap, tetapi pasien menolak dan pulang, sehingga pasien hanya ingin rawat jalan, namun di klaimkan sebagai rawat inap.
3. menarik biaya dari Peserta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

5.25. Episode Perawatan

Episode perawatan adalah jangka waktu perawatan pasien mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap, termasuk konsultasi/pemeriksaan dokter dan/atau pemeriksaan penunjang maupun pemeriksaan lainnya. Untuk setiap episode hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali klaim. Pada sistem INA-CBG ada 2 (dua) episode yaitu episode rawat jalan dan rawat inap, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Episode Rawat Jalan
 - satu rangkaian pertemuan konsultasi antara pasien dan dokter dan/atau pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis dan/atau tatalaksana yang diberikan pada hari pelayanan yang sama.
2. pada pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilakukan pada hari yang sama yaitu pemeriksaan penunjang yang sesuai indikasi medis memerlukan persiapan khusus dan atau kendala kapasitas pelayanan penunjang maka tidak dihitung sebagai episode baru;
3. pasien yang mendapatkan pemeriksaan penunjang dan hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama akan mendapatkan pelayanan konsultasi dokter lanjutan dan merupakan episode baru;
4. dalam hal pelayanan berupa prosedur atau terapi yang berkelanjutan di pelayanan rawat jalan seperti radioterapi, kemoterapi, rehabilitasi medik, rehabilitasi psikososial, transfusi darah, dan pelayanan gigi, episode yang berlaku adalah per 1 (satu) kali kunjungan;
5. pasien yang datang ke FKRTL mendapatkan pelayanan rawat jalan pada satu atau lebih klinik spesialis pada hari yang sama, terdiri dari satu atau lebih diagnosis, dimana diagnosis satu dengan yang lain saling berhubungan atau tidak berhubungan, dihitung sebagai 1 (satu) episode
6. pada rangkaian pertemuan konsultasi medis dalam rangka persiapan operasi maka dihitung sebagai 1 (satu) episode dengan dibuktikan surat konsultasi dokter untuk persiapan operasi;
7. pelayanan IGD yang kurang dari 6 jam dan/atau belum mendapatkan pelayanan rawat inap, termasuk dalam 1 (satu) episode rawat jalan;
8. pasien datang kembali ke rumah sakit dalam keadaan darurat pada hari pelayanan yang sama, maka keadaan darurat tersebut dianggap sebagai episode baru walaupun dengan diagnosis yang sama;
9. pasien yang datang ke IGD dan pada hari yang sama datang kembali ke

rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan, maka tidak dihitung sebagai episode baru;

10. untuk pasien mendapatkan pelayanan rawat inap kurang dari 6 jam yang selanjutnya dirujuk, maka ditetapkan sebagai episode rawat jalan dengan diagnosis yang ditegakkan pada akhir episode.

5.26. Rujuk internal

Merupakan kondisi pasien yang membutuhkan pelayanan dari dpjp lain dimana kondisi pada dpjp utama sudah tidak memerlukan pelayanan kembali (stabil). maka pasien dirujuk dari dokter utama ke dokter lain dan tidak dapat dikembalikan lagi ke dokter utamanya. Rujuk internal dihari yang sama maka diklaimkan satu, namun bila dilakukan rujuk internal dihari yang berbeda dikarenakan jadwal dokter rujukkan tidak ada dihari yang sama maka dapat diklaimkan menjadi dua episode

5.27. Konsul internal

Merupakan kondisi pasien yang masih membutuhkan pelayanan di dokter utama namun juga membutuhkan pelayanan dari dokter lain maka dapat dilakukan konsul internal dan pasien dapat tetap melakukan pemeriksaan lanjutan di dokter utama. Kondisi konsul internal menjadi satu klaim dengan pelayanan dokter utamanya walaupun dilakukan dihari yang berbeda

5.28. Episode Rawat Inap

Satu episode rawat inap adalah satu rangkaian perawatan mulai tanggal masuk sampai keluar rumah sakit termasuk perawatan di ruang rawat inap, ruang intensif, dan ruang operasi. Ketentuan tambahan terkait dengan episode rawat inap yaitu:

1. pelayanan rawat inap yang menjadi kelanjutan dari proses perawatan di rawat jalan atau gawat darurat pada hari yang sama, maka pelayanan tersebut sudah termasuk dalam 1 (satu) episode rawat inap;

Contoh I :

pasien A datang ke rawat jalan tanggal 31 Desember 2020 dan mendapatkan surat perintah masuk rawat untuk tanggal 2 Januari 2021 dengan indikasi medis, maka diklaimkan terpisah.

Contoh II :

pasien B datang ke rawat jalan tanggal 31 Desember 2020 dan mendapatkan surat perintah harus masuk rawat pada hari yang sama, tetapi baru mendapatkan pelayanan rawat inap pada tanggal yang berbeda maka diklaimkan menjadi 1 (satu) episode.

2. pelayanan IGD lebih dari 6 jam termasuk dalam 1 (satu) episode dan diklaimkan rawat inap kelas 3, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan indikasi medis; dan
 - b. telah mendapatkan pelayanan rawat inap dan secara administrasi telah menjadi pasien rawat inap.
 - c. dalam hal pasien telah mendapatkan pelayanan rawat inap yang lama perawatan kurang dari 6 jam dan pasien meninggal termasuk 1 (satu) episode rawat inap;
3. dalam hal pasien dirawat inap dengan rencana operasi atau tindakan invasif lain, dikecualikan untuk pasien gawat darurat, yaitu sebagai berikut:

5.29. Pasien Batal Operasi

1. karena indikasi medis dan harus dilakukan rawat inap atas kondisi tersebut maka ditagihkan sebagai rawat inap dengan diagnosis yang menyebabkan batal operasi dikode Z53.0 (*Procedures not carried out because of contraindication*). pasien batal operasi karena indikasi non medis dan secara administrasi merupakan rawat inap dikode Z53.1-Z53.9, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kurang dari 6 jam diklaimkan sebagai rawat jalan; dan
 - b. lebih dari 6 jam diklaimkan sebagai rawat inap
2. pasien batal operasi yang disebabkan oleh kurangnya persiapan operasi oleh FKRTL karena tidak sesuai dengan standar prosedur tindakan/operasi yang berlaku seperti pemeriksaan penunjang sebelum dilakukan tindakan/operasi maka tidak dapat ditagihkan.

5.30. TIM Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB)

TKMKB adalah representasi dari organisasi profesi, akademisi, dan pakar dalam bidang yang komprehensif, termasuk klinis, manajerial, hukum kesehatan kedokteran, ekonomi kesehatan, mutu layanan kesehatan. Secara khusus, ruang lingkup TKMKB berada pada :

1. Sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai dengan kompetensi (sudah menjadi tugas organisasi profesi).
2. Melakukan kajian kebijakan, programatik, dan monev yang terkait dengan kendali mutu dan kendali biaya, melalui:
 - a) *Utilizationreview*
 - b) Audit medis
 - c) Sistem rujukan
 - d) Sistem pembiayaan kesehatan

Manajemen pelayanan kesehatan Rumah sakit harus membentuk

TKMKB yang terdiri dari:

1. Komite Medis
2. Komite Keperawatan
3. Komite Nakes lain
4. Perwakilan SMF
5. Kepala Asuransi Center
6. Keuangan

Tugas dan wewenang TKMKB, sebagaimana tercantum dalam PMK No.

71 tahun 2013, dideskripsikan lebih lanjut melalui ketentuan umum sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan dengan organisasi profesi dan kegiatan lain untuk mensosialisasikan berbagai hal yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan ;
2. Mengadakan kegiatan dan pertemuan berkala untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *utilization review*;
3. Mengadakan kegiatan dan pertemuan berkala untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan audit medik;
4. Mengadakan pertemuan dengan organisasi profesi dan pemangku kepentingan lain;
5. Melaksanakan kegiatan serta menghimpun isu dan masalah dari masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan peserta JKN di lapangan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada peserta JKN;

5.31. Pelayanan Asuransi Non Bpjs Kesehatan

1. Asuransi Swasta/Perusahaan

Jaminan asuransi swasta diperuntukkan bagi pasien yang memiliki asuransi kesehatan, penggunaan asuransi swasta yaitu dengan dilakukan penggesekan pada saat pasien di pendaftaran dilanjutkan dengan pelaporan pasien masuk maupun pasien pulang kepada petugas asuransi yang dilakukan oleh admin jaminan rumah sakit.

Ketika pasien diperbolehkan pulang oleh DPJP maka petugas admin jaminan melakukan pelaporan kepada asuransi untuk mendapatkan jaminan akhir. Bila pada jaminan akhir pasien memiliki selisih biaya yang harus dibayarkan oleh peserta maka admin jaminan memberikan informasi kepada kasir untuk penyelesaian biaya

2. Jaminan kecelakaan kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja diperuntukkan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dimana peserta telah terdaftar sebagai peserta jaminan kecelakaan kerja. Pengkaliman jaminan kecelakaan kerja dilakukan setiap satu bulan sekali

3. Jasa raharja

Jaminan jasa raharja diperuntukkan bagi pasien yang mengalami kecelakaan di jalan raya. Pengajuan jaminan jasa raharja harus melalui pelaporan kepolisian terlebih dahulu setelah itu manginputkan data pasien beserta laporan kepolisian pada aplikasi TACS yang dimiliki oleh jasa raharja, setelah penginputan pada TACS maka akan muncul jaminan atau penolakan jasa raharja

4. Kelengkapan berkas klaim

1. Asuransi swasta/Perusahaan

- a. Kartu asuransi/identitas perusahaan
- b. Identitas peserta yang berobat
- c. Formulir keluaran asuransi/perusahaan
- d. Jaminan/penolakan dari asuransi/perusahaan
- e. Surat pernyataan keluaran asuransi (bila ada)
- f. Pemeriksaan penunjang (bila ada)
- g. Kuitansi/tagihan
- h. Kelengkapan lain yang meunjang pengajuan klaim sesuai dengan kesepakatan

2. Jaminan kecelakaan kerja

- a. Kartu JKK
- b. Identitas peserta
- c. Eligibilitas peserta
- d. Formulir KK1 sampai KK 3
- e. Kelengkapan perusahaan berupa krologi kejadian, absensi peserta
- f. Pemeriksaan penunjang (bila ada)
- g. Kuitansi/tagihan
- h. Kelengkapan lain yang meunjang pengajuan klaim sesuai dengan kesepakatan

3. Jasa raharja

- a. Identitas peserta
- b. Visume dari kepolisian
- c. Jaminan/penolakan dari jasa raharja

-
- d. Resume medis
 - e. Pemeriksaan penunjang (bila ada)
 - f. Kuitansi/tagihan
 - g. Kelengkapan lain yang menunjang pengajuan klaim sesuai dengan kesepakatan

BAB VI
LOGISTIK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibutuhkan fasilitas pendukung berupa logistik dan alat tulis kantor. Pengadaaan alat penunjang kegiatan asuransi center disiapkan oleh bagian logistik umum

No	Nama barang
1	Kertas F4
2	Amplop besar
3	Klip paper
4	Bulpoin
5	Pensil
6	Stikynote
7	Materai 10.000
8	Spidol
9	Lem kertas
10	Lakban bening
11	Lakban kertas
13	Binder klip

BAB VII

KESELAMATAN PASIEN

7.1. Pengertian Keselamatan Kerja

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

7.2. Tujuan Keselamatan Kerja

Tujuan dari keselamatan kerja di rumah sakit diantara yaitu terciptanya cara kerja yang sehat, aman ,nyaman dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan karyawan di rumah sakit.

7.3. Manfaat Keselamatan Kerja

1. Manfaat bagi RS
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan
 - b. Mempertahankan kelangsungan operasional RS
 - c. Meningkatkan citra RS
2. Manfaat bagi karyawan RS
 - a. Melindungi karyawan dari penyakit akibat kerja
 - b. Mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja
 - c. Manfaat bagi pasien dan pengunjung RS
3. Mutu layanan yang baik
4. Kepuasan pasien dan pengunjung

Aspek keselamatan kerja dilingkungan pelayanan asuransi center diantara nya:

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas di ruangan asuransi center
2. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker
3. Ventilasi dan pencahayaan yang baik di ruang asuransi center

BAB VIII

KESELAMATAN KERJA

UU No 23 tahun 1992 menyatakan bahwa tempat kerja wajib menyelenggarakan upaya kesehatan kerja adalah tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit penyakit atau mempunyai paling sedikit 10 orang. Rumah Sakit adalah tempat kerja yang termasuk dalam kategori seperti disebut diatas, berarti wajib menerapkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja di Unit Asuransi Center

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam hal ini yang dimaksud pekerjaan adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi, yang memungkinkan pekerja berada dalam kondisi sehat dan selamat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat hidup layak sesuai dengan martabat manusia. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap pekerja dalam hal ini pegawai Unit Asuransi Center dan perlindungan terhadap Rumah Sakit. Pegawai adalah bagian integral dari rumah sakit. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja akan meningkatkan produktivitas pegawai dan meningkatkan produktivitas rumah sakit.

Pemerintah berkepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan semua usaha-usaha masyarakat. Pemerintah berkepentingan melindungi masyarakatnya termasuk para pegawai dari bahaya kerja. Sebab itu Pemerintah mengatur dan mengawasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja dimaksudkan untuk menjamin:

- a. Agar pegawai dan setiap orang yang berada di tempat kerja selalu berada dalam keadaan sehat dan selamat.
- b. Agar faktor-faktor produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien.
- c. Agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan.

Faktor-faktor yang menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat digolongkan pada tiga kelompok, yaitu :

- a. Kondisi dan lingkungan kerja
- b. Kesadaran dan kualitas pekerja, dan
- c. Peranan dan kualitas manajemen

Dalam kaitannya dengan kondisi dan lingkungan kerja, kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terjadi bila :

- a. Peralatan tidak memenuhi standar kualitas atau bila sudah aus;
- b. Alat-alat produksi tidak disusun secara teratur menurut tahapan proses produksi;
- c. Ruang kerja terlalu sempit, ventilasi udara kurang memadai, ruangan terlalu panas atau terlalu dingin;
- d. Tidak tersedia alat-alat pengaman;
- e. Kurang memperhatikan persyaratan penanggulangan bahaya kebakaran dll.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan di bagian asuransi center

- a. Penerangan lampu yang cukup baik, menghindarkan kelelahan penglihatan petugas.
- b. Perlu diperhatikan pengaturan suhu ruangan, kelembaban, pencegahan debu, dan pencegahan bahaya kebakaran.
- c. Perlu diperhatikan untuk ventilasi yang ada di ruangan asuransi center
- d. Perlu diperhatikan untuk pemberian kaca antiradiasi pada masing-masing komputer agar terhindar dari penyakit akibat kerja

BAB IX

PENINGKATAN MUTU

Pengendalian mutu merupakan suatu program yang bersifat objektif dan berkelanjutan untuk menilai dan memecahkan masalah yang ada sehingga dapat memberikan kepuasan pada pelanggan mencapai standar yang bermutu. Pengembangan mutu asuransi center yaitu

1. Kesesuaian koding diagnose dan tindakan sesuai dengan INA CBG
2. Kepatuhan petugas terhadap penyetoran rekam medis BPJS Kesehatan <24 jam
3. Kepatuhan DPJP dalam mengisi resume medis
4. Ketidaklengkapan berkas penunjang klaim

BAB X

PENUTUP

Puji syukur yang tak terhingga kami pajatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas terselesaikannya Buku Pedoman Pelayanan Asuransi Center Prima Husada Sukorejo, ini adalah sebagai acuan di dalam setiap kegiatan pengajuan klaim RS Prima Husada Sukorejo demi tercapainya tertib administrasi serta tercapainya target mutu dalam asuransi center

Tidak lupa juga ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan suport dan doanya, terutama kepada semua petugas asuransi center RS Prima Husada Sukorejo, kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang terlibat dalam penyusunan Pedoman Pelayanan Asuransi Center RS Prima Husada Sukorejo.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi tercapainya pedoman suatu pelayanan yang optimal.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 02 Januari 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Sukorejo,



Heni Indra Wulandari. S.Kep.M.Kep